

41. PRAXIS 2 DER DICKDARMRAHMEN

DAUER : 03:23

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Vorstellung von Techniken zur körperlichen Revitalisierung nach einem Kaiserschnitt, die sich auf den Dickdarmrahmen und das Peritoneum konzentrieren. Palpatorische Untersuchung des Abdomens einschließlich der Gewebe- und Wärmereaktion zur Wiederherstellung der faszialen Homogenität. Analyse des terminalen Fulkrums, der Gewebefreisetzen und der dynamischen Anpassung, die nach Beckeninterventionen (z. B. Hysterektomie) erforderlich sind. Klinische Methodik zur Förderung einer harmonischen Gewebeintegration.

PRAXIS 2: DER KOLIKRAHMEN

Ein **Kaiserschnitt** trennt den Körper zwischen oben und unten und erfordert eine **Revitalisierung**. Die Gebärmutter stellt eine Konzentration des **hinteren parietalen Peritoneums** dar. Während der Entwicklung im Peritoneum gibt es eine Konzentration und Kraft, die sich neu zentriert und einen **terminalen Fulcrum** bildet. Dieser Fulcrum ist sowohl embryonal als auch final, und es ist entscheidend, sie wieder ins Bewusstsein zu bringen.

Bei der Palpation ist es wichtig, den gesamten Bauch in die Hände zu nehmen und die Hände entspannt zu halten. Eine zu hohe Atmung kann auf den Wunsch nach **Diskretion** hinweisen. Die empfundene **Wärme** ist ein Austausch zwischen dem Behandler und dem Patienten, bei dem das Gewebe beginnt, Informationen zu geben. Wenn das Gewebe in Abwehrhaltung geht, beginnt sich der untere Bereich zu entspannen, während der obere Teil noch an Homogenität mangelt. Ziel ist es, einen homogenen Zustand wiederherzustellen.

Wenn die Wärme zunimmt, scheinen sich alle Kraftlinien auf den Uterusbereich auszurichten, als ob das Gewebe sein **Nest** wieder integrieren würde. Dies hilft dem Patienten, in sein **inneres Zuhause** zurückzukehren, ähnlich wie jemand, der mit seiner Erde verbunden ist. In diesem Stadium kann der Behandler seinen Kontakt auf den gesamten Körper ausweiten und einen **therapeutischen Prozess** einleiten. Die Integration in den Uterusbereich verstärkt sich, und es entsteht eine größere Homogenität zwischen den Händen.

Im Falle einer **Hysterektomie** ändert sich die Körperdynamik, und der Patient kann einen **Büffelhöcker** entwickeln. Dies erfordert eine Neuausrichtung in mehreren Bereichen. Die Arbeit konzentriert sich auf Gewebepunkte, die eine Gewebefreigabe und eine synchronisierte

Entwicklung ermöglichen. Stützpunkte sind unerlässlich, insbesondere um das **Zwerchfell** zu zwingen, anders zu arbeiten und andere Räume und Öffnungen zu suchen.

Der Behandler kann dann spezifische Bereiche wie den hepatischen und sigmoidalen Bereich ansprechen, um eine vollständige Entspannung zu ermöglichen.



ABB. — Anatomie des Kolon